

Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI)

1. Introducción y relevancia clínica

La **Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)** —actualmente denominada **Trombocitopenia Inmune Primaria (TIP)**— es una **enfermedad autoinmune adquirida**, caracterizada por **trombocitopenia aislada** (<100.000 plaquetas/ μL) en ausencia de otras causas secundarias.

Es la **causa más frecuente de trombocitopenia adquirida en la infancia**, y suele aparecer **posterior a infecciones virales banales** o inmunizaciones.

Aunque su presentación puede ser alarmante por las petequias o equimosis, la mayoría de los casos pediátricos son **benignos, autolimitados y con recuperación espontánea** en 2 a 3 meses.

El diagnóstico es **de exclusión**, y su tratamiento depende del **riesgo de sangrado y recuento plaquetario**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La PTI es una **enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos IgG** dirigidos contra antígenos plaquetarios (principalmente **GP1Ib/IIa** y **GP1b/IX**).

Estos complejos son reconocidos por macrófagos esplénicos y eliminados, lo que causa:

- **Destrucción acelerada de plaquetas en el bazo.**
- **Inhibición de la megacariopoyesis** (producción plaquetaria medular).

El resultado es una **trombocitopenia aislada** con función plaquetaria normal, que aumenta el riesgo de sangrado mucocutáneo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Síntomas más frecuentes

- **Petequias** (puntiformes, no desaparecen a la presión).
- **Equimosis** o hematomas extensos.
- **Epistaxis** o gingivorragia leve.
- Menorragia (en adolescentes).
- Hematuria leve o sangrado digestivo ocasional.

Los **síntomas sistémicos (fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatías)** están ausentes → si aparecen, pensar en otra causa (leucemia, lupus, VIH, etc.).

b.

Forma de inicio

- Habitualmente 1 a 3 semanas después de:
 - Infección viral (rubéola, varicela, EBV, influenza).
 - Vacuna (MMR).

□ En EUNACOM: “Niño de 4 años, post viral, con petequias y plaquetas 25.000/μL, sin visceromegalias → diagnóstico: PTI.”

c.

Examen físico

- Palidez leve (por sangrado).
- Petequias en extremidades, tronco o mucosas.
- Ausencia de fiebre, linfadenopatías o visceromegalias.

d.

Diagnóstico diferencial

Entidad

Elemento diferencial

Leucemia aguda	Pancitopenia, blastos, visceromegalia
Lupus / vasculitis	ANA (+), síntomas sistémicos
Púrpura trombocitopénica trombótica	Hemólisis, fiebre, compromiso neurológico
Infección viral (EBV, VIH)	Serologías positivas
Fármacos (valproato, antibióticos)	Exposición reciente

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico y de exclusión**, basado en:

Examen	Hallazgos
Hemograma completo	Trombocitopenia aislada ($<100.000/\mu\text{L}$)
Frotis periférico	Plaquetas grandes ("jóvenes"), sin blastos
Médula ósea	Normal o megacariocitos aumentados (solo si diagnóstico incierto)
Otros	Pruebas de coagulación, VIH, VHB, ANA (si sospecha secundaria)

Confirmación: trombocitopenia aislada, sin anemia ni leucopenia, sin visceromegalia.

Clasificación clínica (según duración)

Tipo	Duración
Aguda (típica)	<3 meses (90 % de casos pediátricos)
Persistente	3–12 meses
Crónica	>12 meses (≈10 % de los casos)

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE 2023)

a.

Objetivo terapéutico

Prevenir sangrado grave, no necesariamente normalizar las plaquetas.

La mayoría de los niños con PTI aguda **no requieren tratamiento farmacológico**.

b.

Conducta según recuento plaquetario y clínica

Recuento / Síntomas	Manejo
>30.000/ μ L y sin sangrado	Observación, reposo relativo, evitar AAS y traumatismos
<30.000/ μ L o sangrado mucoso moderado	Corticoides orales o IV

Sangrado grave o riesgo vital

Inmunoglobulina IV o metilprednisolona EV; transfusión plaquetaria si necesario

C.

Tratamiento farmacológico

1.

Corticoides

- **Prednisona 1–2 mg/kg/día VO por 2–3 semanas**, luego reducción progresiva.
- Alternativa: **metilprednisolona 30 mg/kg/día EV × 3 días**.

2.

Inmunoglobulina intravenosa (IGIV)

- **Dosis:** 0,8–1 g/kg EV por 1–2 días.
- Rápido aumento plaquetario (24–48 h).
- Indicada en sangrado activo, necesidad quirúrgica o recuentos $<10.000/\mu\text{L}$.

3.

Anti-D inmunoglobulina (en Rh+)

- Alternativa en pacientes Rh positivos sin esplenectomía.

4.

Casos crónicos / refractarios

- Rituximab (anti-CD20).
- Agonistas del receptor de trombopoyetina (eltrombopag, romiplostim).
- **Esplenectomía** en casos seleccionados (solo en >5 años con PTI crónica grave).

d.

Medidas generales

- Evitar deportes de contacto.
 - Suspender fármacos que alteren la hemostasia (AAS, AINEs).
 - Vacunación al día (especialmente si esplenectomizado).
 - Control periódico con hemogramas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Frecuencia	Observaciones
Hemorragia intracraneana	<1 %	Riesgo ↑ si <10.000 plaquetas/ μ L
Sangrado digestivo o genitourinario	Poco frecuente	Vigilancia estrecha
Cronificación (>12 meses)	10–15 %	Predomina en adolescentes o casos con inicio insidioso

Pronóstico:

80–90 % de los niños se recuperan completamente en 3 meses, incluso sin tratamiento.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. PTI = trombocitopenia aislada sin visceromegalia ni blastos.

2. **Causa más frecuente de púrpura aguda infantil.**
3. **Antecedente viral 1–3 semanas antes es clásico.**
4. **Tratamiento sólo si sangrado o plaquetas $<30.000/\mu\text{L}$.**
5. **Primera línea:** prednisona o IGIV.
6. **Médula ósea normal o con megacariocitos aumentados.**
7. **Pronóstico excelente;** la mayoría resuelve espontáneamente.

□ **Errores frecuentes:**

- Solicitar mielograma en todos los casos (no necesario si cuadro típico).
 - Administrar transfusión plaquetaria sin sangrado grave (ineficaz).
 - Usar AINEs o aspirina.
 - Sospechar erróneamente leucemia por petequias aisladas.
 - Indicar esplenectomía en PTI aguda.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **PTI:** trombocitopenia aislada posviral autoinmune.
2. **Diagnóstico clínico de exclusión.**
3. **Médula ósea normal o con megacariocitos $\uparrow$.**
4. **No requiere tratamiento si plaquetas >30.000 y sin sangrado.**
5. **Prednisona o IGIV si sangrado o <30.000 plaquetas.**
6. **Esplenectomía solo en PTI crónica refractaria.**
7. **Recuperación espontánea en la mayoría de los casos.**